

GEHANTEERDE STRATEGIEËN VAN HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN BIJ OPGELEGDE VERANDERINGEN IN ZIEKENHUIZEN

Jorien Stassen¹, Sven De Weerdt¹

1: UHasselt, Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, Agoralaan, 3590 Diepenbeek, België



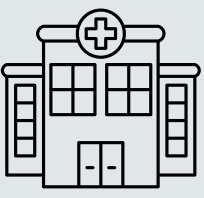
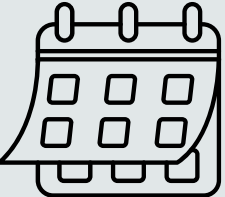
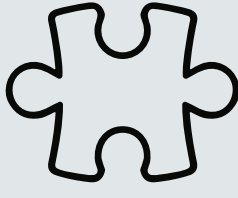
INTRODUCTIE

- Ziekenhuizen bevinden zich in een complexe en voortdurend veranderende context
- Tekort aan verpleegkundigen en stijgende complexe zorgvraag
- Verblijfsafdelingen worden steeds vaker samengevoegd
- Opgelegde verandering = samenvoegen van verblijfsafdelingen
- Hoofdverpleegkundigen spelen een centrale rol in implementatie en begeleiding

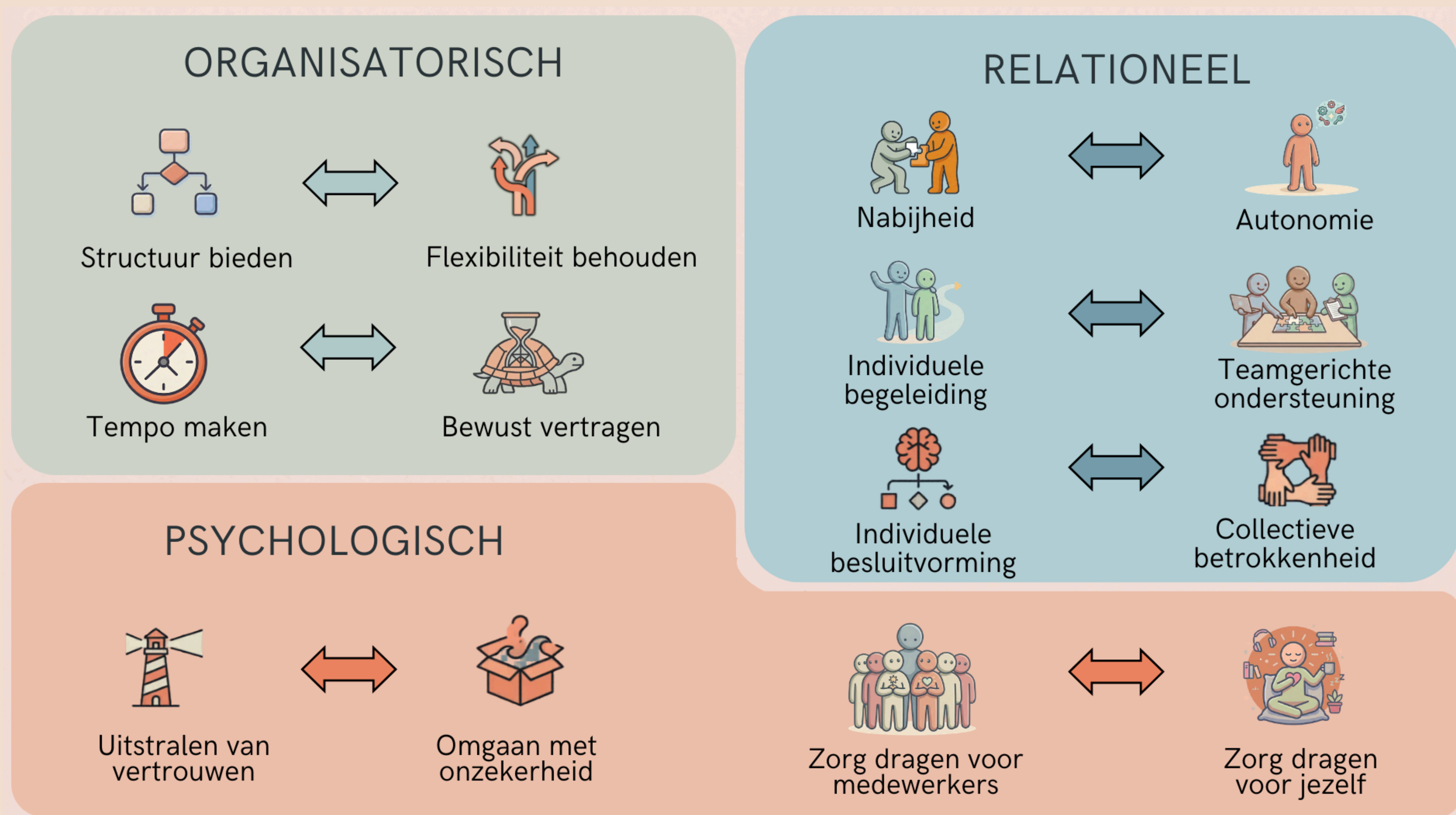
ONDERZOEKSVRAAG

Welke strategieën hanteren hoofdverpleegkundigen bij de opgelegde verandering en welke strategieën faciliteren hierin?

METHODE

-  Hermeneutisch fenomenologisch onderzoek
-  13 participanten: 3 verschillende casussen vanuit verschillende perspectieven belicht
-  Februari - april 2026
-  Semi-gestructureerde interviews
-  Thematische analyse met Nvivo

RESULTATEN



VANUIT DE VERSCHILLENDE PROFIELEN

Managers en stafmedewerkers → beleid, strategie en draagkracht voor hoofdverpleegkundigen

Adjunct- en hoofdverpleegkundigen → vertaling naar werkbare structuur, evenwicht bewaren en draagkracht van verpleegkundigen

Verpleegkundigen → duidelijke afspraken en verwachtingen, structuur als houvast en betrokkenheid

CONCLUSIE

- Geen vast stappenplan → dynamisch en contextafhankelijk proces
- Voortdurend balanceren tussen spanningsvelden op organisatorisch, relationeel en psychologisch niveau
- Hoofdverpleegkundigen verbinden beleid en praktijk en bepalen mee het succes door vertaling, gedragenheid en sturing op afdelingsniveau
- Het opgelegde karakter = de basis van de spanningsvelden → hoofdverpleegkundigen navigeren tussen top-down verwachtingen en de nood aan vertrouwen, betrokkenheid en afstemming in het team

AANBEVELINGEN

- ONDERZOEK**
 - Andere vormen van opgelegde verandering
 - Evolutie psychologische component
- PRAKTIJK**
 - Reflectie, intervisie en coaching rond spanningsvelden
 - Tijd en vertraging als randvoorwaarde
- BELEID**
 - Rekening houden met implementatiecapaciteit
 - Verandering benaderen als complex adaptief proces
 - Emotionele uitputting en verlies van draagkracht voorkomen

METHODOLOGISCHE STERKTES EN LIMITATIES

STERKTES

- Variatie in:
 - functieprofielen
 - ziekenhuizen (meerdere perspectieven)
- Toepassing van triangulatie in de analyse
- Aandacht voor reflexiviteit

LIMITATIES

- Onderzoek uitgevoerd in 3 ziekenhuizen met telkens één casus
- Eén casus met tijdelijk karakter van samenvoeging
- Resultaten gebaseerd op zelfgerapporteerde ervaringen en percepties
- Mogelijke invloed van sociaal wenselijk antwoordgedrag en selectieve herinnering

REFERENTIES

